

失眠的認知行為治療 (CBT-I)：從行為調整到數位療法的完整解析

作者: [Hsu Huai Chiu](#) 分類: [失眠](#)

文章導覽 [隱藏]

[1 為什麼越想睡，越睡不著？](#)

[2 CBT-I 是什麼？](#)

[3 CBT-I 的五大核心策略](#)

[4 最新研究：數位 CBT-I 的崛起](#)

[5 為什麼數位 CBT-I 值得關注？](#)

[6 醫師的觀點：結合科技與臨床經驗](#)

[7 給正在努力入睡的你](#)

[8 小結](#)

[8.1 分享此文：](#)

[8.2 請按讚：](#)

為什麼越想睡，越睡不著？

在門診中，許多人會說：「我吃了藥還是睡不著。」

事實上，藥物能暫時幫助入睡，但若不改變與睡眠相關的行為與想法，失眠問題往往會反覆出現。

因此，醫學界普遍將 認知行為治療 (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBT-I) 列為慢性失眠的一線治療。

CBT-I 是什麼？

CBT-I 是一套經實證驗證、專為失眠設計的行為與心理治療，

目標是透過改變睡眠習慣與思考模式，讓身體重新學會自然入睡。

根據 van der Zweerde 等人於 Sleep Medicine Reviews (2019) 發表的系統性回顧與統合分析，彙整 30 項隨機對照試驗 (RCTs)，結果顯示：

- 失眠嚴重度 (Insomnia Severity Index) 顯著下降，
Hedges $g = 0.64$ (3 個月)、 0.40 (6 個月)、 0.25 (12 個月)。
- 入睡時間平均縮短 20-30 分鐘，
- 睡眠效率提升 約 30-40%。

研究結論指出，CBT-I 的改善效果可持續至少 1 年，
且遠高於安慰組或非主動介入組。
也就是說，CBT-I 並非短期助眠技巧，而是能穩定重建睡眠節奏的治療方式。

CBT-I 的五大核心策略

睡眠衛生教育 (Sleep hygiene)

建立規律作息、避免咖啡因與藍光干擾，讓大腦重新連結「床 = 睡眠」。

睡眠限制法 (Sleep restriction)

限制臥床時間以提升睡眠效率，讓「一上床就想睡」。

刺激控制 (Stimulus control)

睡不著時離開床、想睡才回床，打斷「床 = 清醒」的條件反射。

認知重建 (Cognitive restructuring)

修正「今天沒睡好就完了」等焦慮想法，減少入睡壓力。

放鬆與自律神經調節 (Relaxation training & autonomic regulation)

利用呼吸訓練、正念或 HRV 生理回饋，降低交感神經活性、
促進副交感穩定，幫助身體進入入睡狀態。

最新研究：數位 CBT-I 的崛起

隨著科技發展，CBT-I 已不再侷限於面對面治療。

Hwang 等人於 *npj Digital Medicine* (2025) 發表的

《Systematic review and meta-analysis on fully automated digital CBT-I》

整合 29 項 RCTs、共 9,475 名受試者，結果指出：

- 全自動數位 CBT-I (Fully Automated dCBT-I)
可顯著減輕失眠嚴重度，效果介於中至高度。
- 與對照組相比，臨床改善明顯；雖略低於治療師參與的 CBT-I，
但仍具實質效益。

- 成效與「是否完成課程」關聯不大，顯示治療過程中的主動參與與投入度才是關鍵。

研究者總結：FA dCBT-I 可作為提升可近性的實用選項，若結合專業人員回饋形成「混合式治療模型」，效果最佳。

為什麼數位 CBT-I 值得關注？

對忙碌的現代人或居住偏遠地區患者來說，數位 CBT-I 突破時間與地點限制，讓更多人能接受有效治療。常見形式包括：

- 手機 App 或網站課程（睡眠日記、回饋、放鬆練習）
- 自動化演算法依據每日紀錄提供個別建議
- 結合可穿戴裝置監測睡眠型態

臨床觀察顯示，只要患者持續回報與練習，數位 CBT-I 的效果與傳統面對面治療相近。

醫師的觀點：結合科技與臨床經驗

數位 CBT-I 讓治療更普及，但對於合併焦慮、自律神經失調或其他神經問題的病人，仍建議在醫師或心理師指導下進行。

給正在努力入睡的你

- 長期失眠者不宜自行長期使用安眠藥，可尋求具 CBT-I 或數位 CBT-I 經驗的醫師或心理師協助。
 - 若同時有焦慮、情緒低落、自律神經失調，可結合 CBT-I + HRV 訓練 或 rTMS 療法提升效果。
-

小結

CBT-I 是一套被大量研究證實有效、長期療效穩定的失眠治療。最新證據亦顯示，全自動數位 CBT-I（FA dCBT-I）能顯著改善睡眠品質與入睡時間，為無法長期回診或希望自主訓練的患者提供新選擇。

延伸閱讀：

- [想睡卻睡不著？醫師教你原因與改善方法](#)

- [rTMS 與失眠治療 | 系統性回顧帶來的臨床啟示](#)

失眠衛教專區

← [天氣變化引起的頭痛：氣壓與血管反應](#)

[熱性痙攣 \(Febrile Seizure \) 是什麼？孩子發燒抽搐的原因、處理與預防指南](#) →

留言

發表迴響

更多文章

纖維肌痛症(Fibromyalgia)是什麼?

2025 年 11 月 12 日

週期性肢體動作症候群 (PLMD) 是什麼？睡著後手腳亂動、一直踢，是病嗎？

2025 年 11 月 6 日

神經沒問題 | 桃園邱詡懷醫師

桃園神經內科醫師邱詡懷，專注中風、頭痛、自律神經失調、失眠、失智症與 rTMS 經顱磁刺激治療。主打服務中壢、平鎮、八德，也有病人來自大溪、龍潭、楊梅、大園、蘆竹、龜山、新屋等桃園地區，提供清楚專業的衛教資訊。

本網站參考資源：[台灣神經學學會](#)。聯絡方式: drchiuneuro@gmail.com

[隱私權政策與免責聲明](#) | [神經內科衛教](#) | [rTMS主題頁](#) | [關於邱詡懷醫師](#) | [就診資訊](#) | [桃園rTMS治療](#)



本網站所有內容皆由神經內科醫師邱詡懷撰寫或審核，原創於 drchiuneuro.com。未經授權，請勿全文轉載或複製至其他網站。若需引用，請註明出處並附上原文連結。本網站內容僅供衛教參考，無法取代專業醫師的診斷與治療。

